

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ

Γενικά: Το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας (ΣΑΚΦ) προκαλείται από μερική ή ολική μείωση της αιματικής ροής από την άνω κοίλη φλέβα προς τον δεξιό καρδιακό κόλπο ή σε κακοήγη διήθηση αυτής ή από τον σχηματισμό νεοπλασματικού θρόμβου. Αποτέλεσμα αυτών είναι η αύξηση της ενδοφλέβιας πίεσης και η δημιουργία παράπλευρης κυκλοφορίας, κυρίως μέσω της αζύγου ή των έσω μαστικών φλεβών. Οι ασθενείς με ΣΑΚΦ συνήθως παρουσιάζουν προχωρημένη νόσο και λιγότερο από το 10% αυτών επιζεί περίπου 24-30 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ). Για όσους δεν ανταποκρίνονται στην ΑΚΘ, η μέση επιβίωση είναι μικρότερη από 12 μήνες. Χωρίς ΑΚΘ οι ασθενείς με ΣΑΚΦ επιζούν 30-45 ημέρες.

Αιτία: Συνήθη αίτια είναι οι κακοήθεις όγκοι, όπως καρκίνος πνεύμονα (*βρογχογενές SCLC*), λεμφώματα (*ιδίως non-Hodgkin*) και μεταστατικοί όγκοι στον θώρακα, που ευθύνονται για το 90% των περιπτώσεων ΣΑΚΦ και σπάνια όγκοι του θύμου αδένος, ίνωση μεσοθωρακίου, μετακτινική πνευμονίτιδα, σαρκοείδωση, φυματίωση, ανεύρυσμα θωρακικής αορτής, κ.ά.

Εκτιμάται ότι 15.000 περιπτώσεις ΣΑΚΦ συμβαίνουν κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, με μελέτες να δείχνουν μια διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα του συνδρόμου, ένεκα της συχνής πλέον χρήσης ημιμόνιμων ενδοαγγειακών καθετήρων. Βιβλιογραφικά, η συχνότητα εμφάνισης του ΣΑΚΦ κυμαίνεται από 1 στους 650 έως και 1 στους 3000 ασθενείς με νεοπλασματική νόσο.

Κλινική εικόνα: Χαρακτηρίζεται από διάταση του υποδορίου φλεβικού δικτύου και οίδημα στον θώρακα (*επίφλεβο*), στον τράχηλο, στα άνω άκρα (*βραχίονες*) και στο πρόσωπο (*κυρίως περιοφθαλμικά*), έξαψη, κυάνωση. Συχνά, συνυπάρχει δυσφαγία, βήχας, δύσπνοια ή/και ορθόπνοια, αιμόπτυση, βράγχος φωνής και συριγμός οφειλόμενος στην πίεση των κυρίων βρόγχων και της τραχείας. Σπανιότερα εμφανίζεται κεφαλαλγία, ίλιγγος, αίσθημα πίεσης ή πληρότητας του κρανίου, επίσταξη, κ.ά. Τα συμπτώματα επιδεινώνονται όταν ο ασθενής κατακλίνεται ή όταν σκύβει προς τα εμπρός. Η αιφνίδια εμφάνιση του ΣΑΚΦ, μολονότι ασυνήθης, κρίνεται ως εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση, διότι, εντός ολίγων ωρών, οδηγεί σε ενδοκράνια υπέρταση, εγκεφαλικό οίδημα ή οίδημα λάρυγγα, με ολέθρια αποτελέσματα.

Διαφορική διάγνωση: Η ΔΔ για το ΣΑΚΦ περιλαμβάνει τη φυματίωση, τη μεσοθωρακίτιδα, τη σαρκοείδωση, τη λοίμωξη, τον καρδιακό επιπωματισμό, το ανεύρυσμα θωρακικής αορτής, την αρτηριίτιδα, τον πνευμοθώρακα υπό τάση, το κυστικό ύγρωμα, την πυριτίαση, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Πρωταρχικό μέλημα η σταθεροποίηση του ασθενούς και η αξιολόγηση των Α-Β-С-D-Ε. Παράλληλα, επιχειρούμε ανύψωση της κεφαλής, στην κλίνη, με κλίση άνω των 45°.
2. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (*BP, HR, RR, SpO₂, T°C*) και διενεργείται ΗΚΓ για έλεγχο ρυθμού και αρρυθμιών, ενώ ίσως χρειαστεί ο ασθενής να τεθεί υπό συνεχές monitoring.
3. Επί δύσπνοιας εκτελείται βρογχοδιαστολή με *Berovent/Pulmicort*, με ροή O₂ στα 6 lt/min ή χορηγείται O₂ με μάσκα *Venturi (35-40%)* με ροή 8-12 lt/min, με στόχο SpO₂ > 90-92%.
4. Τοποθετείται ευρεία φλεβική γραμμή και λαμβάνονται: γενική αίματος, β/χ έλεγχος: *Glu, Urea, Creat, UA, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, AST/ALT, γ-GT, ALP, CRP, INR, aPTT, D-dimers*, κ.λπ.
5. Χορηγούμε κρυσταλλοειδή: 1000 ml NaCl 0,9% ή R/L, αργά στάγδην, για υποστήριξη.
6. Χορηγούμε διουρητικά, όπως Φουροσεμίδα: 2-3 amp. *Lasix* 20 mg, στον ορό (ή iv-bolus), με προσοχή, διότι μπορεί να μειώσουν την καρδιακή παροχή, με συνέπεια βαριά υπόταση.
7. Χορηγείται Δεξαμεθαζόνη: 1 amp. *Dexamethasone* 4 mg (iv ή im), ανά 6 ώρες.
8. Επί απουσία κινδύνου αιμορραγίας, χορηγούνται αντιπηκτικά ή επιχειρείται θρομβόλυση.
9. Ενημερώνεται για το συμβάν ο ογκολόγος - ιατρός του ασθενούς. Λαμβάνονται οδηγίες και προγραμματίζεται α/α ή CT/MRI θώρακος ή βρογχοσκόπηση (με *FNA*) ή σχήμα ΧΜΘ ή ΑΚΘ ή διακομίζουμε άμεσα τον ασθενή στο Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση, όπου πιθανώς να χρειαστεί και τοποθέτηση ενδοαγγειακού stent στην άνω κοίλη φλέβα.